

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 19	Bezeichnung des Dokumentes: Pneumonienprophylaxe	

Durchführender:

- Pflegefachkräfte (PFK)/Pflegehilfskräfte (PHK)

Pflegeziel:

- Förderung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
- Vermeidung von Sekretanhäufung und von Infektionen
- Verbesserung der Lungenbelüftung und des Atemvolumens

Indikation:

- bei Patienten mit längerer Liegedauer bzw.
- bei Gefahr der Entstehung einer Pneumonie bzw.
- nach ärztlicher Anordnung

Kontraindikation:

- bei Ablehnung des Patienten

Vorbereitung:

- Patienten informieren
- Materialien für die Pflegemaßnahmen bereitlegen

Material:

- Lagerungshilfen
- eventuell Materialien für die Basale Stimulation

Durchführung:

- die erste pflegfachliche Einschätzung (bei Aufnahme) zur Pneumoniegefährdung erfolgt durch die PFK in den Themenfeldern in der „Strukturierten InformationsSammlung“ (SIS) und es erfolgt ggf. eine Aufnahme in die Maßnahmenplanung
- tritt eine Pneumoniegefährdung später neu hinzu, erfolgt eine Eintragung im Berichtblatt und die Anpassung der Maßnahmenplanung
- Ist eine Beratung erfolgt, wird dies inhaltlich kurz im zutreffenden Themenfeld beschrieben, später notwendig werdende Beratungen sind im Berichtblatt zu beschreiben
- grundsätzlich dient das Berichtblatt zur Erfassung veränderter pflegerischer Situationen als anlassbezogene Evaluation in akuten Situationen oder bei besonderen Ereignissen oder Veränderungen

Maßnahmen der Pneumonienprophylaxe sind:

Atem unterstützende Lagerung:

- Hochlagern des Oberkörpers
- **Halbmondlagerung:** Patient liegt mit gestreckten Beinen in Rückenlage, der rechte Arm liegt seitlich am Körper und die linke Hand im Nacken, nun zieht der Patient die rechte Hand, die nah am Körper liegt, in Richtung des rechten Fußes, bis eine halbmondähnliche Lage erreicht ist, dadurch Dehnung der oberen und seitlichen Lunge, die überdehnte Seite wird besser belüftet, für Dehnung der rechten Seite wird die rechte Hand in den Nacken gelegt und die linke Hand bewegt sich am Körper zum linken Fuß, Stellung sollte 3x tägl. für 5 - 15 Minuten beibehalten werden, nur bei Patienten anwendbar, die im Hüft- und Wirbelsäulenbereich keine Einschränkungen haben
- **V- oder Schiffchenlagerung:** zwei spezielle Lagerungskissen oder zwei nicht zu prall gefüllte Federkissen, die zu „Schiffchen“ geformt werden, werden so gelegt, dass sie sich

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 19	Bezeichnung des Dokumentes: Pneumonieprophylaxe	

überkreuzen und ein „V“ bilden (im Liegen und im Sitzen möglich), soll die Lungenspitzenatmung gefördert werden, legt sich der Patient so in die Kissen, dass er mit dem Nacken auf der Kissenspitze zum Liegen kommt (das „V“ ist umgedreht), der Patient bekommt eine extra Kopfunterstützung, die Arme werden auf den Enden der Kissen gelagert, nicht länger als 20 Minuten 2-3mal täglich (nie in der Häuslichkeit so allein lassen)

- soll die Flankenatmung gefördert werden, müssen die Kissen so gelegt werden, dass sie von den Schulterblättern zum Steißbein reichen
- **Drehdehnlage** mit dem Ziel der Entspannung und Atemerleichterung, der Patient wird seitlich gelagert, das obere Bein leicht angewinkelt, der obere Arm liegt hinter dem Kopf, dann den Oberkörper so weit wie möglich nach hinten drehen. Die Lagerung kann im Wechsel durchgeführt werden. (GS MDS Essen Demenz)

Atemübungen:

- den Patienten regelmäßig zum Durchatmen anhalten, das Atmen bewusstmachen
- Bauchatmung (Hände auf den Bauch legen und wegatmen lassen, beim Senken leichten Druck ausüben)
- Thoraxatmung (Hände seitlich auf den Thorax legen und wegatmen lassen, beim Senken leichten Druck ausüben)
- Flankenatmung (Hände an der Basis der Lungenflügel anlegen und wegatmen lassen)
- es ist besser, den Patienten zur gänzlichen Ausatmung als zur tiefen Einatmung anzuregen

Maßnahmen zum Lösen und Abhusten des Sekrets:

- Oberkörper hoch lagern
- Vibrationen durch leichte Klopfungen in Richtung Hauptbronchus
- den Patienten zum tiefen Durchatmen und Abhusten auffordern (Zellstoff, Nierenschale oder Sputumbecher bereithalten)
- Luftbefeuchtung und evtl. Inhalation (auf ärztliche Anordnung)
- den Patienten viel trinken lassen (Verflüssigung des Sekrets)

Mobilisation:

- zu ausreichender Bewegung motivieren

Basale Stimulation:

- Maßnahmen in liegender oder sitzender Position (135-Grad-Lagerung)
- rhythmische Einreibung des Rückens mit einem W/O-Präparat auf warmen Handflächen am Nacken beginnend zum Rückenende hin
- kreisende Bewegungen mit beiden Händen gleichzeitig und unter Ausübung von Druck mit Daumen und Zeigefinger und unter Anpassung an den Atemrhythmus des Patienten

Einreibungen:

- Einreibungen beispielsweise mit ätherischen Ölen (Zitrone, Lavendel, Pfefferminze, Thymian, Eukalyptus) ggf. in Verbindung mit Wärmeanwendung (Wickel, Auflagen, Bade- oder Waschzusatz) können atemfördernd wirken. (GS MDS Essen Demenz)

Beatmungspflichtige Patienten:

- Die Pflege und Versorgung von beatmungspflichtigen Patienten ist in einem gesonderten Standard geregelt.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 Intensivpflege-Halle-GmbH
Kennzeichen/ Fundstelle VA - III.5 - 19	Bezeichnung des Dokumentes: Pneumonieprophylaxe	

Hinweis Hygiene:

Die Empfehlung des RKI zur „Prävention nosokomialer Pneumonien“ sind zwingend zu berücksichtigen. Hierzu erfolgt eine jährliche Belehrung.

Nachbereitung:

- Dokumentation der Leistungsdurchführung
- Dokumentation aller Auffälligkeiten des körperlichen und seelischen Zustands oder Verweigerungen von Pflegemaßnahmen
- ggf. Abfall entsorgen
- bei erheblichen Abweichungen und Auffälligkeiten Information an die PDL
- bei Notwendigkeit Anpassung der Maßnahmeplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seiten	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2023		001	3	Verw./MA